

# पेल्विक अंग प्रोलैप्स

WARWIKI

रोगी जानकारी · जब पेल्विक अंग खिसककर उभार या दबाव पैदा करें

पेल्विक अंग प्रोलैप्स (Pelvic Organ Prolapse) तब होता है जब पेल्विक अंगों — मूत्राशय, गर्भाशय, या मलाशय — के आसपास की सहारा देने वाली मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और ये अंग योनि में या बाहर की ओर दबाव डालने लगते हैं। इससे उभार या दबाव का अहसास होता है। यह बहुत आम है, खतरनाक या कैंसर नहीं है, और इसके लिए व्यायाम से लेकर सपोर्ट device तक और सर्जरी तक कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं।

## इस स्थिति के बारे में

प्रोलैप्स उस दीवार के अनुसार नाम पाता है जो खिसकती है:

- **अगली दीवार** (मूत्राशय) — सिस्टोसील (Cystocele)
- **पिछली दीवार** (मलाशय) — रेक्टोसील (Rectocele)
- **ऊपरी भाग** (गर्भाशय, या hysterectomy के बाद योनि का ऊपरी सिरा)

### सामान्य लक्षण:

- योनि के मुँह पर **उभार या गाँठ** जो दिखे या महसूस हो
- पेल्विक **दबाव या भारीपन**, अक्सर दिन के अंत में या भारी सामान उठाने पर बढ़े
- मूत्राशय या आँत पूरी तरह खाली न होना; कभी-कभी उभार को दबाकर पेशाब या मल निकालना ("splinting")

## कारण

जो भी पेल्विक सहारे को कमज़ोर करे: **गर्भावस्था और प्रसव**, रजोनिवृत्ति और उम्र बढ़ना, लंबे समय तक ज़ोर लगाना (कब्ज या खाँसी), भारी सामान उठाना, पहले की पेल्विक सर्जरी, अधिक वज़न, और पारिवारिक प्रवृत्ति।

## शब्दों को समझें

### प्रोलैप्स

जब कोई पेल्विक अंग अपनी सामान्य जगह से खिसक जाए।

### Cystocele

मूत्राशय का अगली योनि दीवार में उभरना।

### Rectocele

मलाशय का पिछली योनि दीवार में उभरना।

### Vaginal vault

योनि का ऊपरी सिरा, जो hysterectomy के बाद खिसक सकता है।

### Pessary

योनि में रखा जाने वाला हटाने योग्य सपोर्ट, जो अंगों को ऊपर रखता है।

### Splinting

मूत्राशय या आँत खाली करने में मदद के लिए उभार को दबाना।

### पेल्विक फ़्लोर

पेल्विक अंगों को सहारा देने वाली मांसपेशियाँ।

### POP-Q

प्रोलैप्स कितना आगे है, यह मापने वाली जाँच।

**क्या इलाज ज़रूरी है?** केवल तभी, जब यह आपको परेशान करे। प्रोलैप्स खतरनाक नहीं है, इसलिए अगर लक्षण हल्के हैं तो बस निगरानी रख सकते हैं। जब यह आपकी सुविधा या दैनिक जीवन को प्रभावित करे, तब आप कई प्रभावी विकल्पों में से चुन सकते हैं — कोई एक “सही” उत्तर नहीं है, और आप बाद में अपना निर्णय बदल सकते हैं।

## जाँच कैसे होती है

- **पेल्विक जाँच**, अक्सर खड़े होकर या ज़ोर लगाते हुए, यह देखने के लिए कि कौन सी दीवार कितनी खिसकी है
- मूत्राशय और आँत के लक्षणों की समीक्षा
- अगर पेशाब भी लीक होता है तो कभी-कभी **bladder-function testing**

## इलाज कैसे होता है (चरण दर चरण)

- 1 **निगरानी** अगर परेशानी न हो, साथ ही रोकथाम (कब्ज का इलाज, भारी उठाने से बचें, वज़न नियंत्रित करें)।
- 2 हल्के प्रोलैप्स के लिए **पेल्विक फ़्लोर व्यायाम (केगेल) / physical therapy**।
- 3 **Pessary** — एक हटाने योग्य सपोर्ट जो बिना सर्जरी के उभार से राहत देता है।
- 4 **सर्जरी** — सहारा बहाल करने, योनि बंद करने (colpocleisis), या suspension के लिए। हर विकल्प का अपना handout है।

## इसके साथ जीना

- मल नरम रखें और **ज़ोर लगाने से बचें**; चिकित्सा टीम की सलाह से ज़्यादा भारी न उठाएँ।
- पेल्विक फ़्लोर व्यायाम करें; खाँसी और वज़न को नियंत्रित करें।
- Pessary एक दीर्घकालिक समाधान हो सकता है, केवल अस्थायी नहीं।

### यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- आप **पेशाब नहीं कर पा रहे** या मल नहीं हो रहा
- उभार में **दर्द हो, खून आए, या घाव/छाला** हो जाए
- बुखार हो, या उभार वापस अंदर न जाए

## याद रखने योग्य तीन बातें

1. प्रोलैप्स एक आम, गैर-खतरनाक स्थिति है जिसमें पेल्विक अंग खिसककर उभार या दबाव पैदा करते हैं।
2. इलाज तभी करें जब परेशानी हो — निगरानी और व्यायाम से लेकर pessary या सर्जरी तक विकल्प उपलब्ध हैं।
3. ज़ोर लगाने और भारी उठाने से बचें। यदि मूत्राशय या आँत खाली न हो, या उभार में दर्द या घाव हो, तो तुरंत देखभाल लें।